

PROTOCOLO UOU – NEUMONÍA LEVE / INFECCIÓN RESPIRATORIA Hospital San Agustín de Avilés

1. OBJETIVO

- Manejo protocolizado de pacientes con diagnóstico de neumonía de bajo riesgo Escala CURB-65 (Puntuación 0 o 1) ya valorados en urgencias con previsión de posibilidad de Alta para tratamiento ambulatorio en 24 horas, o traslado en 12-24 a HFA, para descanso, control de la fiebre o el dolor, hidratación adecuada y antibioterapia.

2. EVALUACIÓN INICIAL

- Anamnesis completa con exploración física, constantes vitales (FR, FC, PA, SpO2)
- ECG 12 derivaciones
- Rx tórax (PA y Lat)
- Analítica: hemograma, Bioquímica con PCR/procalcitonina (si disponible), función renal
- Gasometría Arterial si SpO2 < 92-92%
- Antígenos urinarios (neumococo/legionella) y Test Antígenos Virus Respiratorios

3. OBJETIVO PARA INGRESO EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Tras identificar neumonía de bajo riesgo: neumonía adquirida en la comunidad que presenta un pronóstico favorable y un riesgo de mortalidad casi nulo. Escala CURB-65 (Puntuación 0 o 1)

Escala CURB-65 1

- Iniciar tratamiento precoz:

MEDIDAS GENERALES:

- Canalización vía venosa periférica
- Oxigenoterapia si insuficiencia respiratoria con soporte necesario para conseguir SpO2 superior a 92%
- Antitérmicos sin T^a>38°C.

ANTIBIOTERAPIA:

- Beta-lactámico (amoxicilina-clavulánico 1 g o Ceftriaxona 2 g) y Azitromicina 500 mg/24h.
- Levofloxacino 500mg/12h en monoterapia.

- Evaluar respuesta en 12-24h.
 - Nivel de conciencia
 - Frecuencia Respiratoria
 - Saturación O2

- Presión Arterial y Frecuencia cardiaca.
- Tª

- Decidir destino: alta a domicilio/Hospitalización a Domicilio (HAD) Hospital Fundación Avilés (HFA) / ingreso HUSA

4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Diagnóstico de neumonía
- CURB-65 bajo (0–1, valorar 2 según contexto, si edad >65 años y alteración de otro parámetro de CURB65 previsiblemente corregible en 24 horas)
- Estabilidad hemodinámica
- SpO2 >91-92% con bajo flujo o basal
- Tolerancia oral (o recuperable en 12-24 horas)
- Plan terapéutico definido: posibilidad de tratamiento ambulatorio, o traslado en 12-24 a HAD o HFA, para continuar tratamiento.

5. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Inestabilidad hemodinámica: Disminución del estado de conciencia (Confusión, desorientación) PAS<90-80 mmHg o PAS >180 mmHg . Frecuencia Cardiaca >120 lpm. Síncope.
- Insuficiencia respiratoria grave: Taquipnea, cianosis, estridor, tiraje intercostal o supraclavicular, agotamiento respiratorio. Frecuencia Respiratoria >30 o <10 rpm. Presión arterial de oxígeno (PaO₂) < 60 mmHg, Presión de dióxido de carbono (PaCO₂) > 50 mmHg
- Necesidad de alto flujo / VMNI
- Sepsis o sospecha de sepsis grave
- Deterioro clínico rápido (1-2 horas durante la atención en urgencias)
- Comorbilidad descompensada importante
- Signos radiológicos de cavitación, derrame pleural y/o bilateralidad.

6. TRATAMIENTO

- Antibiótico empírico precoz:
Amoxicilina-ácido clavulánico 2g + 200 mg iv y Azitromicina 500 mg iv
Levofloxacino 500mg iv

- Oxígeno si $SpO_2 < 92\%$ (Si paciente con diagnóstico EPOC objetivo de oxigenoterapia SpO_2 88-92%)
- Broncodilatadores si componente obstructivo: Agonista B-Adrenérgico de acción corta (Salbutamol) + Anticolinérgico (Bromuro de Ipratropio) en cámara de inhalación o en inhalador de polvo seco.
- Hidratación oral y/o intravenosa
- Analgésicos si dolor, o Antitérmicos si $T^a > 38^\circ$ paracetamol 1g iv/6h infundido en 15 min. Metamizol magnésico 2g/6h (diluido en 100 ml de SSF o SG 5%) infundido en 20 min.

7. MONITORIZACIÓN

- Constantes Vitales (FR, FC, PA)
- Saturación basal de O_2
- Tolerancia oral
- Reevaluación cada 4-6h
- Control gasometría arterial si $SpO_2 > 92\%$ a las 4-6 horas
- Analítica al alta de la UOME

8. CRITERIOS DE BUENA EVOLUCIÓN

- Estabilidad clínica (Buen nivel de conciencia, mantiene PAS > 90 mmHg y < 180 mmHg, FC 60-100 lpm, FR 12-20 rpm)
- Mejoría de disnea
- $SpO_2 > 92\%$ O SpO_2 basal del paciente
- Tolerancia al tratamiento iv puesto en la unidad y comprobación de tolerancia oral.

9. CRITERIOS DE MALA EVOLUCIÓN

- Aumento de disnea.
- Empeoramiento gasométrico
- Inestabilidad hemodinámica
- Intolerancia oral

10. DESTINO

- Alta a domicilio si estable, tratamiento oral posible y buen soporte domiciliario (reseñando radiografía de control en 4 semanas, y control por su MAP)
- Ingreso hospitalario si mala evolución o criterios de gravedad
- Derivación a Hospital Fundación Avilés si :

- • Disponibilidad por parte de HFA
- • Paciente frágil
- • Dificultad social
- • Necesidad de cuidados intermedios
- • Evolución lenta pero estable

- CRITERIOS DE INGRESO EN HOSPITALIZACION A DOMICILIO

CRITERIOS LOGÍSTICOS Y SOCIOFAMILIARES:

- **Consentimiento:** El paciente y su cuidador/familia deben aceptar el ingreso de forma voluntaria.
- **Cuidador principal:** Ante pacientes dependientes o con necesidades puntuales se requiere la presencia de un cuidador responsable, familiar o tutor, durante el tiempo que dure el proceso que pueda asumir las necesidades del paciente y se mantenga en contacto con la unidad.
- **Soporte de comunicación:** El domicilio debe disponer de teléfono operativo.
- **Domicilio:** La residencia del paciente debe reunir unas condiciones higiénicas mínimas y localizarse en el área de cobertura de la unidad de HAD, aproximadamente a una distancia que no supere los 20 minutos en coche. Se adjunta área de cobertura en anexo.
- **Social:** ausencia de problemática social.

CRITERIOS CLÍNICOS :

- **Gravedad baja o moderada:** Puntuación en escalas de riesgo (CURB-65: 0-2 puntos).
- **Estabilidad hemodinámica:** Sin datos de shock ni fallo respiratorio agudo.
- **Control respiratorio:** Saturación de oxígeno superior al 90% sin necesidad de oxigenoterapia de alto flujo.
- **Síntomas digestivos tolerables:** Ausencia de íleo paralítico o vómitos incoercibles que requieran hidratación intravenosa masiva.
- Neumonía de bajo riesgo (CURB-65: 0-1) en pacientes **frágiles** y en pacientes **crónicos complejos** que precisen un seguimiento al alta por su complejidad.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- **Gravedad elevada:** Necesidad de soporte ventilatorio o flujos altos de oxigenoterapia.
- **Complicaciones radiológicas:** Derrame pleural masivo, cavitación o afectación multilobar extensa.
- **Comorbilidades descompensadas:**
 - Insuficiencia renal aguda
 - Cardiopatía isquémica
 - Diabetes mellitus con descompensación severa (cetoacidosis, situación hiperosmolar).
 - Tromboembolia pulmonar en fase inestable o muy reciente.

- Que **no** cumpla alguno de los criterios logísticos y sociofamiliares.

11. Bibliografía

1. Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Grupo Infecciones de Urgencias INFURG-SEMES
2. Guía Clínica para la prescripción de antibioterapia empírica de infecciones prevalentes en urgencias. (actualización 2026)
3. Neumonía adquirida en la comunidad. Normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Actualización 2020Community-Acquired Pneumonia. Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery (SEPAR) Guidelines. 2020 UpdateNeumonía adquirida en la comunidad. Normativa de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Actualización 2020Community-Acquired Pneumonia. Spanish Society of Pulmonology and Thoracic Surgery (SEPAR) Guidelines. 2020 Update
4. Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias Y Emergencias: Guía
5. Diagnóstica Y Protocolos de Actuación. 7a ed. Montero Pérez FJ, Jiménez Murillo L, editores.
6. Elsevier; 2023.

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE CON:

NEUMONÍA

En un paciente con Neumonía ingresado en una unidad de observación de urgencias, la enfermera debe vigilar de forma continua la evolución respiratoria, hemodinámica y neurológica para detectar deterioro precoz o complicaciones.

Signos y síntomas a vigilar y registrar

- **Estado respiratorio**
 - ♣ **Frecuencia respiratoria** (taquipnea es signo de gravedad).
 - ♣ **Disnea** o aumento del trabajo respiratorio.
 - ♣ **Uso de músculos accesorios** y tiraje.
 - ♣ **Saturación de oxígeno (SpO₂)** y necesidad creciente de oxígeno.

- ♣ **Cianosis** en labios o dedos.
- ♣ **Tipo de respiración:** superficial, irregular o fatigada.
- ♣ **Auscultación pulmonar:**
 - crepitantes,
 - disminución del murmullo vesicular,
 - sibilancias o roncus.
- **Tos:**
 - Frecuencia
 - Eficacia
 - presencia de hemoptisis.
- **Características del esputo:**
 - ♣ cantidad,
 - ♣ color,
 - ♣ viscosidad,
 - ♣ mal olor.
- **Signos vitales y estado hemodinámica:**
 - ♣ **Temperatura** (fiebre o hipotermia).
 - ♣ **Frecuencia cardíaca** (taquicardia).
 - ♣ **Presión arterial:**
 - hipotensión puede sugerir sepsis.
 - ♣ **Perfusión periférica:**
 - relleno capilar,
 - frialdad,
 - sudoración.
- **Estado neurológico:**
 - ♣ **Nivel de conciencia:**
 - somnolencia,
 - confusión,
 - agitación,
 - desorientación.
 - ♣ Especialmente importante en ancianos por riesgo de Sepsis o hipoxemia.
 - ♣
- **Balance y estado general**
 - **Diuresis.**

- **Hidratación** y tolerancia oral.
- **Fatiga extrema** o debilidad.
- **Dolor torácico pleurítico.**

Registros Específicos en la Historia Clínica

▪ Vigilancia de tratamientos

- Respuesta a:
 - o oxigenoterapia,
 - o antibióticos,
 - o broncodilatadores,
 - o fluidoterapia.
- Efectos adversos de medicación.

▪ Complicaciones que deben sospecharse

- Insuficiencia respiratoria.
- Derrame pleural.
- Absceso pulmonar.
- Sepsis/shock séptico.
- Agudización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o Asma si existen antecedentes

Signos de alarma

Avisar de inmediato si aparecen:

- Saturación < 90% o descenso progresivo.
- FR > 30 rpm.
- Hipotensión.
- Confusión aguda.
- Cianosis.
- Empeoramiento brusco de la disnea.
- Silencio auscultatorio.
- Oliguria.
- **Datos de sepsis:**
 - o fiebre persistente,
 - o taquicardia,
 - o hipotensión,

- o alteración mental.

BIBLIOGRAFÍA:

1. - Ferrer Tarrés JM, Prat Marín A, Tomás Vecina S. Revisión de la utilización de las áreas de observación de urgencias hospitalarias. Med Clin (Barc). 2007;128(6):224-31. Quirónsalud.
2. - Inhaladores de cartucho presurizado: técnica de inhalación. Escuela de Pacientes Neumología. Madrid: Quirónsalud; 2023. Disponible en: <https://www.quironsalud.com> [Acceso 04 sept 2026]. Servicio Andaluz de Salud.
3. - Guía de diseño y organización de servicios de urgencias hospitalarias. Sevilla: Consejería de Salud; 2016. Soler Gómez Y, Fernández Viñado DM, Martínez Fernández C, et al.
4. - Atención de enfermería al paciente politraumatizado por accidente de tráfico: enfoque integral en la emergencia. Rev Sanitaria Invest. 2025;6(7):e2660-7085. Sánchez Reyes E, Pinal Moreno E, Ortega Vargas MC.
5. - Guía clínica de enfermería del enfermo con insuficiencia cardíaca. Rev Enferm IMSS. 2004;12(3):155-62. Grupo de Trabajo de EPOC SEMERGEN.
6. - Protocolo de manejo del paciente con EPOC agudizado en urgencias. SEMERGEN. 2020;46(Supl 1):1-12. Gómez Martínez A, González Vallejo ML, García Cuesta P.
7. - Plan de cuidados enfermeros en el paciente con EPOC y neumonía según taxonomía NANDA-NIC-NOC. Rev Enferm CyL. 2018;10(2):45-58. Gobierno de Canarias.
8. - Guía de atención a emergencias sanitarias en los centros educativos: Traumatismos II. Las Palmas: Consejería de Educación; 2021. Universidad de Salamanca.
9. - Guía docente Enfermería en Urgencia y Riesgo Vital. Grado en Enfermería. Ávila: USAL; 2024-2025. Mayo Clinic.
10. - Inhaladores para el asma: ¿cuál es el indicado para usted? Rochester: Mayo Foundation; 2024. Disponible en: <https://www.mayoclinic.org> [Acceso 04 sept 2026].
11. - Guía de actuación en urgencias de la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE)
12. - Cuidados de enfermería en el paciente crítico en urgencias de García González, M., et al. (2020)
13. - Manejo del paciente con dolor torácico en urgencias de López López, J., et al. (2019)
14. - Emergencias (revista de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias)
15. - Enfermería de Urgencias (revista especializada en cuidados de enfermería en urgencias)
16. - SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias) - Guías y protocolos

17. - SEEUE (Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias) - Recursos y documentos